

PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: LESIONES TRAUMÁTICAS DEL TOBILLO

G. Alonso Claro, A. Roces Fernández, F.J. Madera González.

TRAUMATISMO DE TOBILLO

Anamnesis: Antecedentes personales de enfermedades sistémicas, cirugías previas en la zona, presencia o no de traumatismo, tiempo de evolución del cuadro, presencia de fiebre. Preguntaremos por la presencia de fallo del tobillo.

Exploración física: Ver si hay edema, rubor, cicatrices, fístulas, heridas o deformidades. Comprobar la temperatura del tobillo, la presencia de tumoraciones, palpar las interlíneas del tobillo y maléolos, así como los ligamentos colaterales, sindesmosis y ligamento deltoideo. Movilidad normal de 10-20° de flexión dorsal y de 40-50° de flexión plantar. Se valorará el cajón anterior y las pruebas de estrés: bostezos a la inversión forzada y la eversión forzada.

Pruebas complementarias: solicitaremos siempre las proyecciones AP, Lateral y de la mortaja. Suelen ser suficientes para llegar a un diagnóstico.

La indicación de realizar un estudio radiológico está definida por las **reglas de Ottawa**:

- Solo realizar radiografía si presenta alguna de las siguientes:
- Dolor a la presión ósea en los 6 últimos cm del maléolo medial o lateral
- Dolor a la palpación de la base del 5º metatarsiano o del escafoides tarsiano
- Imposibilidad para cargar y caminar más de 4 pasos.

ESGUINCE DE TOBILLO

Mecanismo lesional: Tiene lugar una distensión, rotura parcial o completa de los ligamentos del tobillo tras una inversión (afectación del ligamento lateral externo) o eversión forzada (afectación del ligamento deltoideo).

Exploración física:

Se manifiesta con dolor, inflamación y equimosis variando la sintomatología en función del grado. El dolor sigue el trayecto de los fascículos lesionados. Se explorarán los bostezos articulares; un bostezo muy marcado sugiere una rotura completa del ligamento.

- **Grado I:** leve
- **Grado II:** rotura parcial de los ligamentos sin signos de inestabilidad articular.
- **Grado III:** Graves, rotura completa de los ligamentos e inestabilidad articular.

Tratamiento:

Esguinces simples se resuelven en pocos días con medidas de apoyo: frío local, vendaje compresivo, reposo y elevación. Los esguinces moderados y severos necesitarán de inmovilización con férula suropédica durante 4 a 6 semanas seguido de ejercicios funcionales.

FRACTURA-LUXACIÓN DE TOBILLO

Mecanismo lesional:

Las fracturas de tobillo son una de las consultas más frecuentes en urgencias. Generalmente suceden por un mecanismo indirecto, la mayoría son fracturas maleolares (60-70%) seguidas de las bimalleolares (15-20%) y las trimaleolares (7-12%). Las fracturas abiertas son raras (2%).

Exploración física.

Buscar zonas inflamadas y equimóticas, deformidades y zonas dolorosas o crepitación a la palpación.

Pruebas complementarias.

Solicitaremos las proyecciones AP, lateral de tobillo. La proyección de la mortaja para valorar la integridad o no de la sindesmosis. Si hay dolor en peroné proximal solicitar una radiografía de toda la pierna (descartar fractura de Maissonneuve: proximal de peroné + apertura de sindesmosis)

La clasificación de las fracturas más usada es la de Weber-Danis. Hay que prestar atención en la radiografía al maléolo peroneo; altura de la fractura y desviación.

Las fracturas del maléolo peroneo infrasindesmales (tipo A de Weber) son fracturas estables. El resto de fracturas, inestables.

Tratamiento.

Ante una fractura luxación de tobillo lo primordial es la reducción de la luxación y la posterior inmovilización. Para la inmovilización colocaremos una férula suropédica a 90º de flexión del tobillo.

Una vez reducida la fractura:

- **Fractura estable:** tratar conservadoramente con un botín de yeso
- **Fracturas inestables:** tratamiento quirúrgico



ROTURAS DEL TENDÓN DE AQUILES

Mecanismo lesional.

El tendón de Aquiles es el tendón más grande del cuerpo. El mecanismo de rotura suele ser la contracción brusca y súbita del tríceps sural con la rodilla en extensión. Lesión muy relacionada

con la práctica deportiva.

Exploración física:

El paciente refiere dolor intenso y súbito en la cara posterior de la pierna (signo de la pedrada). A la exploración física el paciente es incapaz de ponerse de puntillas y explorando la zona posterior de la pierna se aprecia una hendidura en la zona de la lesión (hachazo).

Maniobra de Thompson:

Patognomónica de la integridad del tendón. En decúbito prono, se presiona la masa muscular del tríceps sural se observa la flexión plantar del pie, si no sucede el tendón está roto. El uso de la ecografía puede ayudar al diagnóstico, pero este es eminentemente clínico.

Tratamiento:

El tratamiento ortopédico de entrada consiste en la inmovilización en equino y varo con una bota de yeso. La mayoría de estas lesiones se tratan mediante cirugía actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- Sánchez Hernández, N., García García, J.M. Fracturas luxación de tobillo. En: Forriol Campos, F. Manual del Residente de C.O.T. SECOT 2009. P 431-440.
- Casas Ramos, P. Taveras Bonilla, OA. Lesiones de Pelvis y Miembros Inferiores. En: Rodríguez García, M.C., Fernández-Samos Gutiérrez, R. Criterios de Actuación en Urgencias. León 2013. EOLAS ediciones. p: 356-360
- Otilio Covaro, A., Llauradó, M., Granero, J. Fracturas del pilón tibial. Fracturas maleolares. En Granero, J., Otero, R., Peidro, L. Manual de Traumatología. Medical & Marketing Communications. 2012. P:301-312.